Um:bruch

re:shape – Denkfabrik für gesellschaftlichen Wandel

POSITIONSPAPIER PP-003

Regress-Transparenzportal: Warum Deutschland eine anonyme Meldeplattform für ärztliche Regressforderungen braucht

Ein Open-Source-Konzept zur Schließung der größten Datenlücke im deutschen Gesundheitswesen

Um:bruch – Denkfabrik für gesellschaftlichen Wandel | April 2026 | Version 2.8

Zusammenfassung. Das deutsche Wirtschaftlichkeitsprüfsystem kennt zwei Wege zum Regress: die Auffälligkeitsprüfung (V1, statistisches Screening) und die Einzelfallprüfung (V2, Kassenantrag bei konkretem Verdacht). Für V1 liegt die Durchsetzungsquote unter 1 %. Für V2 existieren **keine öffentlichen Verfahrensstatistiken** — obwohl allein in einer KV-Region 20.000 Anträge jährlich gestellt werden. Gleichzeitig berichten 72 % der Hausärzte eigene Regresserfahrung (Ribbat et al. 2023; V1+V2 zusammen, keine Verfahrenstrennung). Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man die Verfahren trennt: Die beruhigende Statistik stammt aus V1, die ärztliche Erfahrung überwiegend aus V2. Das System produziert drei Scanner (Kosten, Formfehler, Abrechnung), aber keiner prüft medizinische Versorgungsqualität. Dieses Konzept skizziert ein anonymes, verifiziertes Meldeportal (Wahlkabinen-Prinzip), das die größte Datenlücke im System — die V2-Verfahrensstatistik — erstmals empirisch schließen würde.

Schlagworte: Regress, Transparenz, GLP-1, Gesundheitspolitik, Open Source, Patientenversorgung

Inhaltsverzeichnis

1 Executive Summary **5**

2 Methodische Einordnung **5**
2.1 Was wir messen . . . 5
2.2 Vier Referenzrahmen . . . 6
2.3 Forschungsbeitrag . . . 6

3 Problemanalyse **7**
3.1 Zwei Wege zum Regress — und warum die Unterscheidung entscheidend ist . . 7
3.2 Der Systemwiderspruch: Warum es zwei Verfahren gibt — und warum sie sich widersprechen . . . 7
3.3 Was wir wissen: Die Zahlen — getrennt nach Verfahren . . . 7
3.3.1 V1 (Auffälligkeitsprüfung): Niedrige Durchsetzungsquote, gut dokumentiert 7
3.3.2 V2 (Einzelfallprüfung): Daten existieren — aber nicht als integrierte Statistik 8
3.3.3 Ist die Angst berechtigt? . . . 8
3.4 Was wir nicht wissen: Die Datenlücken . . . 9
3.4.1 Wissenschaftlicher Widerspruch: Reliabilität und Validität . . . 9
3.4.2 Ökonomischer Widerspruch: Stichprobe vs. Mikromanagement . . . 10
3.4.3 Interessenkonflikt bei der Einzelfallprüfung . . . 10
3.4.4 Drei Scanner, keine Qualitätsprüfung . . . 10
3.4.5 Der doppelte Zertifikatsfehler: Was das System tatsächlich misst . . . 11
3.4.6 Strukturelle Asymmetrie: Beratungsschutz nur bei V1 . . . 11
3.5 Bürokratiekosten und Kodierungskomplexität . . . 11
3.5.1 Zeitaufwand . . . 12
3.5.2 16.000 ICD-Codes — ein eigener Beruf . . . 12
3.5.3 Einzige Branche ohne Fehlertoleranz . . . 12
3.6 Formfehler und Eigentumsparadoxon . . . 12
3.6.1 BSG B 6 KA 9/24 R: 491.000 EUR für einen Stempel . . . 12
3.6.2 Tatsächlicher Schaden: Null . . . 13
3.6.3 Das Eigentumsparadoxon . . . 13
3.7 Konkrete Patientenschäden . . . 13
3.7.1 Systemische Muster . . . 14
3.8 Vertraulicher Erstattungsbetrag — das Paradoxon . . . 15
3.9 Was daraus folgt: Warum diese Datenlücken geschlossen werden müssen . . . 15

4 Marktlücke und Alleinstellung **16**
4.1 Was existiert . . . 16
4.2 Was gebraucht wird, um die Datenlücken zu schließen . . . 16
4.3 Internationale Einordnung . . . 16

5 Rechtliche Bewertung **16**
5.1 Gesamtbewertung . . . 17
5.2 Stärkstes Argument: KV RLP Präzedenzfall . . . 17
5.3 Rechtliche Pflichten des Betreibers . . . 17
5.4 DSGVO-Matrix: Rechtsgrundlagen explizit . . . 17
5.5 Vorsorge: Rechtsanwaltliche Prüfung . . . 18

6 Technisches Konzept **18**
6.1 Architekturprinzip: Wahlkabine . . . 18
6.2 Tech-Stack (MVP) . . . 19
6.3 Datenfluss . . . 20

7 Datenarchitektur und Anonymisierung **20**
7.1 Meldungsfelder (strukturiert, Dropdowns) . . . 20
7.2 Anonymisierungsregeln . . . 21
7.3 Datenaufbewahrung . . . 21

8 Identitätsverifizierung **21**
8.1 Anforderung: Nur Ärzte, aber anonym . . . 21
8.2 Empfohlenes Verfahren (Phasenmodell) . . . 21
8.3 Methodisches Prinzip: Statistische Robustheit vor absoluter Verifikation . . . 22
8.4 Anti-Fake-Maßnahmen . . . 22
8.5 Was NICHT funktioniert . . . 23

9 MVP-Definition **23**
9.1 Scope MVP (v0.1) . . . 23
9.2 Erfolgskennzahlen MVP . . . 23

10 Governance und Betrieb **23**
10.1 Anforderungen an die Trägerorganisation . . . 23
10.2 Rollen-Struktur . . . 24
10.3 Redaktionsrichtlinien . . . 24

11 Finanzierung **24**
11.1 Kosten MVP . . . 25
11.2 Finanzierungsquellen . . . 25
11.3 Langfristige Nachhaltigkeit . . . 25

12 Zeitplan **25**
12.1 Phase 1: Grundlagen (Monat 1–2) . . . 25
12.2 Phase 2: MVP-Entwicklung (Monat 3–4) . . . 25
12.3 Phase 3: Soft Launch (Monat 5–6) . . . 26
12.4 Phase 4: Öffentlicher Launch (Monat 7–8) . . . 26
12.5 Phase 5: Skalierung (ab Monat 9) . . . 26

13 Risiken und Gegenmaßnahmen **26**

14 Kooperationspartner **27**
14.1 Priorität 1 (sofort ansprechen) . . . 27
14.2 Priorität 2 (ab Phase 4) . . . 27
14.3 Priorität 3 (ab Phase 5) . . . 27

15 Quellen und Rechtsgrundlagen **27**
15.1 Gesetze und Verordnungen . . . 28
15.2 BSG-Rechtsprechung . . . 29
15.3 Institutionelle Quellen . . . 29
15.4 Studien und Analysen . . . 29

16 Anhang: Namensvorschläge **29**

Änderungshistorie **31**

1 Executive Summary

In Deutschland existiert keine Plattform, auf der Ärzte anonym und verifiziert melden können, ob und in welcher Höhe sie von Krankenkassen regressiert wurden. Auch international gibt es nichts Vergleichbares.

Das deutsche Wirtschaftlichkeitsprüfsystem kennt zwei Wege zum Regress: die **Auffälligkeitsprüfung** (V1, statistisches Screening, Durchsetzungsquote unter 1 %) und die **Einzelfallprüfung** (V2, Kassenantrag bei Formfehler-Verdacht). Für V2 existieren keine öffentlichen Verfahrensstatistiken — obwohl allein in der KV Nordrhein jährlich 20.000 Anträge gestellt werden. Die beruhigende "unter 1 %"-Statistik stammt aus V1; die ärztliche Regresserfahrung (72 % der Hausärzte, Ribbat et al. 2023) überwiegend aus V2. Die Angst ist berechtigt — sie bezieht sich auf ein anderes Verfahren als die Statistik. Ein einziger Formfehler kann zu existenzbedrohenden Rückforderungen führen (BSG B 6 KA 9/24 R: 491.000 EUR — Stempel statt Unterschrift, alle Verordnungen medizinisch korrekt).

Dieses Projekt schließt die größte Datenlücke im System: Ein anonymes, verifiziertes Meldeportal für ärztliche Regressforderungen, das erstmals V2-Verfahrensausgänge, Formfehler-Anteile und Vergleichsquoten empirisch erfasst. Betrieben von einer gemeinnützigen Trägerorganisation, geschützt durch Art. 5 GG und legitimiert durch das Präzedenzbeispiel des KV-RLP-Regress-Rankings. *Dieses Konzept wird der Öffentlichkeit zur Umsetzung angeboten — die Autoren suchen Träger, nicht Eigentum.*

Begleitstudie: Die wissenschaftliche Tiefenanalyse der Befunde, auf die sich dieses Konzept stützt, findet sich im Begleitpaper *ST-001 — Systemtheoretische Aufarbeitung der Regressangst* (v0.12, 85 Seiten). Das vorliegende Konzeptpapier referenziert die Befunde, die ausführliche Begründung steht in der Studie.

Klarstellung zur Position: Dieses Konzept ist *pro-Governance*, nicht *anti-Regress*. Der Regress als Instrument der Wirtschaftlichkeitsprüfung wird nicht infrage gestellt. Was infrage gestellt wird, ist die fehlende Transparenz über seine tatsächliche Wirkung. Wir wollen den Regress nicht abschaffen, sondern messbar machen — damit eine evidenzbasierte Reformdebatte überhaupt möglich wird.

Kosten MVP: ca. 800–2.500 EUR (Detailkalkulation siehe Abschnitt 10)
Zeitrahmen MVP: 8–12 Wochen
Gemeinnütziger Zweck: Förderung der Volksbildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO) und des demokratischen Staatswesens (Nr. 24)

2 Methodische Einordnung

Dieses Konzept ist kein Aktivismus — es ist ein Messinstrument. Es überträgt bewährte wissenschaftliche Ansätze auf ein neues Feld und schließt damit eine Forschungslücke.

2.1 Was wir messen

Wir messen nicht Regress — wir messen Regress-induzierte Unterversorgung. Der Regress selbst ist ein bekanntes, rechtlich geregeltes Verfahren. Was fehlt, ist die empirische

Erfassung seiner systemischen Nebenwirkungen: vorauseilender Gehorsam, Quartalsende-Effekte, Überweisungskaskaden, Therapievermeidung.

2.2 Vier Referenzrahmen

1. Pharmakovigilanz → übertragen auf Regulationsschäden

Die WHO-Pharmakovigilanz (gegr. 1968, 157 Mitgliedsstaaten, über 30 Mio. Berichte in VigiBase) erfasst unerwünschte Arzneimittelwirkungen durch Spontanmeldungen. Das Regress-Transparenzportal überträgt dieses Prinzip: Statt Nebenwirkungen von Medikamenten erfassen wir Nebenwirkungen von Regulierung. Das BfArM-Spontanmeldesystem (nebenwirkungen.bund.de) dient als methodische Blaupause.

2. Incident Reporting (CIRS) → nicht für Fehler, sondern für Sanktionsrisiken

Critical Incident Reporting Systeme sind seit 2014 in deutschen Krankenhäusern verpflichtend. Sie erfassen anonyme Beinahe-Zwischenfälle als Lerngrundlage (APS/ÄZQ, CIRSmedical.de). Das Regress-Portal nutzt dieselbe Methodik — anonyme, strukturierte, sanktionsfreie Meldung — wendet sie aber auf Sanktionsrisiken statt auf Behandlungsfehler an.

3. Chilling-Effect-Messung → empirisch operationalisiert

Der *Chilling Effect* — die abschreckende Wirkung regulatorischer Drohungen auf erlaubtes Verhalten — ist in der Rechtswissenschaft seit Jahrzehnten beschrieben, aber im Gesundheitswesen kaum empirisch gemessen. Goetz et al. (2024, BMC Primary Care) zeigten: 27 % der deutschen Hausärzte berichten starke Angst vor rechtlichen Konsequenzen, 50 % veranlassen wöchentlich unnötige Laboruntersuchungen aus Defensivmedizin. Eine Meta-Analyse (Moosazadeh et al. 2023) beziffert die Prävalenz von Defensivmedizin auf 75,8 % weltweit. Das Regress-Portal operationalisiert diesen Effekt erstmals für das deutsche Verordnungswesen.

4. Governance-Pharmakovigilanz: Surveillance für regulatorische Nebenwirkungen

Klassische Surveillance-Systeme überwachen Krankheiten. Das Konzept einer *Governance-Pharmakovigilanz* — die systematische Anwendung von Surveillance-Methoden auf regulatorische Nebenwirkungen — wird in ST-001 (Abschn. 8.1) als neues Paradigma eingeführt. Cha et al. (2026, J. Business Logistics) zeigten, dass PDMP-Enforcement in den USA zwar Opioid-Verschreibungen um 6,1 % senkte, aber Heroin-Todesfälle um 50,1 % steigen ließ. Das Regress-Portal wäre international das erste Instrument, das regulatorische Nebenwirkungen im Gesundheitswesen systematisch erfasst.

2.3 Forschungsbeitrag

Die Kombination dieser vier Ansätze ist bislang nicht besetzt. Das Regress-Transparenzportal wäre:

- Das erste **Spontanmeldesystem für regulatorische Nebenwirkungen** im Gesundheitswesen
- Die erste **empirische Operationalisierung des Chilling Effect** im deutschen Verordnungswesen
- Ein Beitrag zur **Versorgungsforschung**: Der Sachverständigenrat identifizierte bereits 2001 Unterversorgung als unterschätztes Problem (SVR-Gutachten 2000/2001). Seitdem fehlen Instrumente, um regulatorisch bedingte Unterversorgung zu messen.

3 Problemanalyse

3.1 Zwei Wege zum Regress — und warum die Unterscheidung entscheidend ist

Vertragsärzte in Deutschland unterliegen der Wirtschaftlichkeitsprüfung nach §§ 106, 106b SGB V. Zwei grundlegend verschiedene Verfahren können zu einem Regress führen. Ihre Unterscheidung ist für alles Folgende zentral, wird aber in der öffentlichen Debatte fast nie vorgenommen:

	V1: Auffälligkeitsprüfung	**V2: Einzelfallprüfung**
Auslöser	Statistische Abweichung vom Fachgruppendurchschnitt	Konkreter Antrag einer Krankenkasse
Initiator	Prüfungsstelle (KV + Kassen, neutral)	Krankenkasse (Antragstellerin)
Was geprüft wird	Kostenvolumen, regional auch Wirkstoffquoten (DDD)	Formale Korrektheit einzelner Verordnungen
Beratung vor Regress	**Ja** (§ 106b Abs. 2)	**Nein** (§ 106b Abs. 2 S. 4)
Charakter	Statistisches Screening	Gezieltes Verdachtsverfahren
Ausschlussfrist	2 Jahre (seit TSVG 2019)	2,5 Jahre (seit GVWG 2021)

Warum diese Unterscheidung so wichtig ist: Fast alle öffentlich zitierten Statistiken ("unter 1 % Regressquote") beziehen sich auf **V1 und V2 zusammen** — ohne Verfahrenstrennung. Da V1 die große Mehrheit der Verfahren stellt und eine sehr niedrige Durchsetzungsquote hat, dominiert sie die Gesamtstatistik. Die tatsächliche Regresswahrscheinlichkeit bei V2 (Einzelfallprüfung) ist unbekannt, weil sie nie separat publiziert wird. Genau diese Datenlücke macht das System intransparent — und genau hier setzt dieses Konzept an.

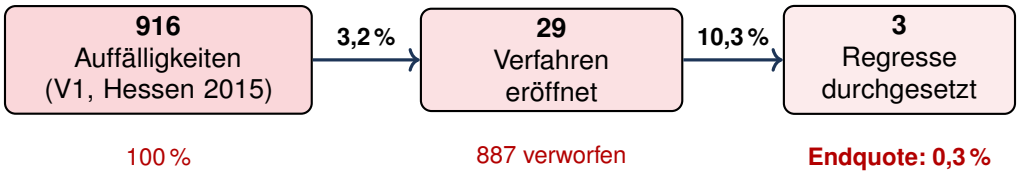
3.2 Der Systemwiderspruch: Warum es zwei Verfahren gibt — und warum sie sich widersprechen

Die beiden Prüfverfahren widersprechen sich fundamental: wissenschaftlich, ökonomisch und rechtlich. Diesen Widerspruch muss man verstehen, bevor man die Zahlen interpretiert.

3.3 Was wir wissen: Die Zahlen — getrennt nach Verfahren

3.3.1 V1 (Auffälligkeitsprüfung): Niedrige Durchsetzungsquote, gut dokumentiert

Für die Auffälligkeitsprüfung (V1) existieren öffentlich zugängliche Daten aus mehreren KV-Regionen. Die Dropout-Rate ist hoch:



KV-Bezirk (nur V1)	Auffälligkeiten	Regresse	Durchsetzungsquote
Hessen 2015	916	3	0,3 %
Hessen 2016	1.106	8	0,7 %
Hessen 2017	513	4	0,8 %
Nordrhein (stat. Prüfung)	13.500 Praxen	∼2/Jahr	0,015 %
Thüringen 2015	22 Prüfungen	0	0 %
BaWü 2022	∼21.500 Ärzte	21	0,097 %

Diese Zahlen zeigen: Die Auffälligkeitsprüfung (V1) führt sehr selten zu Regressen. Die "unter 1 %"-Zahl des Virchowbundes wird primär von diesen V1-Daten dominiert.

3.3.2 V2 (Einzelfallprüfung): Daten existieren — aber nicht als integrierte Statistik

V2-Daten existieren: Das BMG nennt im GVSG-Referentenentwurf 2024 ca. **47.000 V2-Verfahren bundesweit** (2022). Der SpiFa meldet für Bayern **13.332 festgesetzte Regresse** (2024) bei ∼24.000 Vertragsärzten — Durchschnittsbetrag 334 EUR, ∼70 % Bagatelle unter 300 EUR. Was fehlt, ist die **Aufschlüsselung**: nach V2a (Unwirtschaftlichkeit) vs. V2b (Formfehler), nach Kassenart, nach Ausgang (Regress/Vergleich/Einstellung), nach Betragsklasse. Allein in der KV Nordrhein: jährlich ca. 20.000 Einzelfallprüfungsanträge bei gleichzeitig nur ∼2 V1-Regressen pro Jahr. **Genau diese Aufschlüsselung soll PP-003 liefern.**

3.3.3 Ist die Angst berechtigt?

Die Ribbat-Studie (2023, n=770, TU München; **V1+V2 zusammen, keine Verfahrenstrennung**) liefert einen Befund, der die "unter 1 %"-Beruhigung fundamental infrage stellt:

- **72 % der Hausärzte** und 59 % der Orthopäden hatten **tatsächlich mindestens einmal einen Regress erlebt**
- 47 % / 55 %: Regressgefahr beschäftigt im Praxisalltag "stark oder sehr stark"
- 37 % / 47 %: Ärztliches Handeln "stark beeinflusst"
- 51 % der Hausärzte: Überweisen "zumindest gelegentlich trotz Indikation" an Spezialisten

72 % persönliche Regresserfahrung bei einer offiziellen Quote von "unter 1 %" — dieser Widerspruch ist kein Wahrnehmungsfehler der Ärzte, sondern eine **Definitionsdivergenz** (ST-001, CORE4): Die "unter 1 %" messen nur V1-Regresse, nur rechtskräftig (Schicht 1). Die 47.000 V2-Verfahren (Schicht 3) fehlen. Der Faktor: ca. 500×. Dazu kommt die Summierung: Bei V2 ist das Risiko *pro Verordnung* gering — aber ein Arzt mit ca. 3.000 Verordnungen pro Quartal akkumuliert über 10 Jahre 120.000 Angriffspunkte. **Kleines Risiko pro Fall, großes Risiko pro Arzt — die Angst ist berechtigt.**

Ergänzend: 46,7 % der ca. 13.900 befragten Medizinstudierenden nennen "drohende Regressforderungen" als Niederlassungshindernis (KBV-Berufsmonitoring 2018). Die Angst erreicht also selbst Personen, die noch nie niedergelassen waren.

3.4 Was wir nicht wissen: Die Datenlücken

Das System hat blinde Flecken, die nicht zufällig, sondern strukturell sind. Die folgende Übersicht trennt Bekanntes von Unbekanntem:

Das wissen wir	Das wissen wir nicht
V1-Durchsetzungsquote ($<$1 %)	V2-Durchsetzungsquote (nie publiziert)
Anzahl V2-Anträge in einzelnen KVen ($\sim$20.000/Jahr Nordrhein)	Verfahrensausgänge der V2-Anträge (Regress / Vergleich / Einstellung)
47 % der Hausärzte: Verhalten beeinflusst (Ribbat 2023)	Ob Patienten tatsächlich unterversorgt werden (keine Outcome-Daten)
Formfehler lösen 100 %-Regress aus (BSG B 6 KA 5/09 R)	Wie viele V2-Regresse auf Formfehler vs. Sachfehler zurückgehen
Kosten des Prüfsystems (nicht bilanziert, Niskanen)	Nutzen des Prüfsystems (Abschreckungswirkung unquantifiziert)
Kassen haben Echtzeit-Prüfsoftware (scanacs u. a.)	Ob Kassen systematisch screenen (§ 106b setzt “zufälligen” Verdacht voraus)

Diese Daten existieren — in den Prüfungsstellen, den Beschwerdeausschüssen, den Sozialgerichten. Sie werden nur nicht veröffentlicht. Die 99,7 %-Verwerfungsrate der V1-Verfahren ist für ein statistisches Screening *erwartbar* und Ergebnis eines funktionierenden Schutzstufenmodells (Anhörung, medizinische Berücksichtigung, Beratung vor Regress). Die entscheidende offene Frage betrifft V2: Wie hoch ist die tatsächliche Durchsetzungsrate bei Einzelfallprüfungen, und wie viel Geld fließt über Vergleiche (außerhalb der Gerichtsstatistik)? Neun IFG-Anfragen zur Schließung dieser Lücken wurden im April 2026 eingereicht (siehe ST-001, Anhang C).

Termination without Determination: Enden ohne Feststellung

Ein zusätzliches epistemisches Problem: Die öffentlichen Statistiken messen nicht, *wie* Verfahren enden. Regressverfahren können durch Ablehnungsbescheid, informellen Vergleich, Antragsrücknahme, Verjährung oder Gerichtsurteil enden. Da bei V2 geschätzt 70–80 % der betroffenen Ärzte einen **Vergleich** akzeptieren (typisch 30–50 % des Regressbetrags), findet die Durchsetzung überwiegend außerhalb des Gerichts statt. Der Vergleich *ist* die Durchsetzung — er erscheint nur in keiner Statistik. Beide Seiten meiden das Gericht aus rationalen Gründen: Der Arzt, weil er bei festgestelltem Formfehler verliert; die Kasse, weil zu viele Gerichtsverfahren die Aufmerksamkeit auf ihre Antragspraxis lenken. Die eigentliche Messebene wäre der *Geldfluss* (Regressvolumen), nicht die Gerichtsurteile — aber genau diese Daten werden nicht publiziert. Eine vollständige Analyse in ST-001, Abschn. 2.4.

3.4.1 Wissenschaftlicher Widerspruch: Reliabilität und Validität

Zwei Messinstrumente, die denselben Gegenstand messen (Wirtschaftlichkeit einer Arztpraxis), müssten konvergente Ergebnisse liefern. Die Auffälligkeitsprüfung (statistisch, Fachgruppenvergleich) kann einen Arzt als *unauffällig* einstufen — während die Einzelfallprüfung (auf Kassenantrag) zeitgleich einzelne Verordnungen desselben Arztes als *unwirtschaftlich* beanstandet.

Entweder die statistische Prüfung übersieht systematisch Probleme — dann ist sie invalide. **Oder** die Einzelfallprüfung produziert systematisch falsche Alarme — dann ist sie unreliabel. Beides gleichzeitig kann logisch nicht zutreffen. In der Messtheorie wäre eine solche Divergenz zweier Instrumente ein Konstruktionsfehler.

3.4.2 Ökonomischer Widerspruch: Stichprobe vs. Mikromanagement

Die Auffälligkeitsprüfung ist eine statistische Stichproben-Qualitätskontrolle — entwickelt, um genau die Fälle zu identifizieren, die näher betrachtet werden müssen. Ergebnis: unauffällig. Normalerweise würde ein rationaler Akteur daraus schließen: kein Handlungsbedarf.

Stattdessen stellen Krankenkassen parallel tausende Einzelfallprüfungsanträge. Allein in der KV Nordrhein: **20.000 Einzelfallprüfungsanträge pro Jahr** — bei gleichzeitig nur 23 statistischen Prüfungen in drei Jahren mit ca. 2 Regressen pro Jahr. Die Kosten dieses Parallelsystems — Personal der Prüfungsstellen, Beschwerdeausschüsse, Sozialgerichtsverfahren — werden nirgends bilanziert.

3.4.3 Interessenkonflikt bei der Einzelfallprüfung

Prüfungsart	Initiator	Entscheider	Neutralität
Auffälligkeitsprüfung	Prüfungsstelle (neutral)	Prüfungsstelle	Gegeben
Einzelfallprüfung	**Krankenkasse**	Prüfungsstelle	Eingeschränkt

Bei der Einzelfallprüfung ist die Krankenkasse gleichzeitig **Zahlerin** (finanzielles Interesse an geringeren Ausgaben), **Antragstellerin** (wählt aus, welche Verordnungen geprüft werden) und **Empfängerin** des Regressbetrags. Dies konstituiert ein strukturelles Interessenkonfliktpotenzial: finanzielle Interessen des Antragstellers und Entscheidungsbefugnis der Prüfungsstelle sind systemimmanent nicht vollständig entkoppelt.

3.4.4 Drei Scanner, keine Qualitätsprüfung

Das Wirtschaftlichkeitsprüfsystem betreibt drei Screening-Mechanismen. Keiner davon prüft medizinische Versorgungsqualität (ausführliche Analyse in ST-001, Abschn. 2.8):

- **V1 (Auffälligkeitsprüfung):** Scannt Kostenabweichung vom Fachgruppendurchschnitt. Prüft nicht, ob die Versorgung medizinisch angemessen war.
- **V2a (Einzelfallprüfung — Wirtschaftlichkeit):** Prüft Wirtschaftlichkeit einzelner Verordnungen. Medizinische Begründung und Kostendifferenz möglich. Prüft nicht, ob die Therapieentscheidung medizinisch richtig war.
- **V2b (Einzelfallprüfung — Formfehler):** Scannt formale Korrektheit (Unterschrift, ICD↔PZN, Dosierung). Medizinische Korrektheit irrelevant.
- **Retax (Apotheke):** Scannt formale Korrektheit der Abrechnung. Prüft nicht, ob der Patient das richtige Medikament bekommen hat.

Niemand prüft, ob der Patient ausreichend versorgt wurde (§ 12 SGB V), ob eine Unterlassung stattfand, ob die Therapieentscheidung leitliniengemäß war, oder ob der Arzt aus Angst *weniger* verordnet hat als medizinisch geboten. Das System bestraft Formfehler — nicht Überversorgung im medizinischen Sinne. Ein Arzt, der formal korrekt dokumentiert aber medizinisch schlecht behandelt, ist unsichtbar. Ein Arzt, der exzellente Medizin macht aber einen Formfehler produziert, ist maximal exponiert. Ein Arzt, der aus Angst gar nicht erst verordnet, wird nie geprüft — aber der Patient trägt die Folgen (Unterversorgung, Überweisung, Hospitalisierung). Der Arzt selbst riskiert im Einzelfall eine Behandlungsfehler-Klage (§ 280 BGB) — aber die hat kein Prüfverfahren als Auslöser, sondern den Patienten.

3.4.5 Der doppelte Zertifikatsfehler: Was das System tatsächlich misst

Beide Prüfverfahren messen nicht, was § 12 SGB V als Schutzziel benennt — bedarfsgerechte, zweckmäßige Versorgung. Sie messen Proxys (Ersatzgrößen, die stellvertretend für das eigentliche Ziel gemessen werden):

Verfahren	Anspruch	Tatsächlich gemessen
Auffälligkeitsprüfung	wirtschaftliche Versorgung	Kostenabweichung vom Fachgruppendurchschnitt
Einzelfallprüfung	medizinische Unwirtschaftlichkeit im Einzelfall	formale und dokumentarische Angreifbarkeit
Kein Verfahren	**§ 12 SGB V**	**wird systematisch nicht gemessen**

Die Einzelfallprüfung beansprucht, medizinische Unwirtschaftlichkeit zu prüfen, misst aber faktisch formale Angreifbarkeit. Formfehler sind: billig zu prüfen, eindeutig, angstwirksam, nicht medizinisch streitbar. Das erzeugt eine inverse Selektionslogik: Das System selektiert gegen Dokumentationsschwäche, nicht gegen Versorgungsdefizite. In der Sozialwissenschaft ist dieses Phänomen als *Goodhart's Law* bekannt: Wenn eine Kennzahl zum Steuerungsziel wird, hört sie auf, eine gute Kennzahl zu sein (Goodhart 1975; Campbell 1979). Der Zertifikatsfehler ist keine Anomalie, sondern eine bekannte systemische Pathologie von Proxy-Messungen. **Medizinische Angemessenheit wird nur außerhalb des Regresssystems zertifiziert** — in Schlichtungsverfahren und Arzthaftungsprozessen. Das Transparenzportal (PP-003) löst diesen Zertifikatsfehler nicht, sondern macht ihn sichtbar und messbar. Die vollständige Analyse in ST-001, Abschn. 2.5. Einschränkung: Der Zertifikatsfehler trifft in voller Schärfe V2b (Formfehler). V1 berücksichtigt medizinische Besonderheiten im Schutzstufenmodell. V2a lässt medizinische Verteidigung zu.

3.4.6 Strukturelle Asymmetrie: Beratungsschutz nur bei V1

Ein zentraler struktureller Defekt des Systems betrifft den Schutz "Beratung vor Regress". Dieser ist in § 106b Abs. 2 SGB V **nur für die Auffälligkeitsprüfung (V1)** verankert: Ein erstmals auffälliger Arzt wird beraten, bevor ein Regress durchgesetzt wird. Für die **Einzelfallprüfung (V2) ist dieser Schutz gesetzlich ausgeschlossen** (§ 106b Abs. 2 S. 4 SGB V): Hier folgt nach Kassenantrag unmittelbar eine sanktionsrechtliche Entscheidung — ohne pädagogischen Zwischenschritt.

Diese Asymmetrie bedeutet: Ein Arzt, der im statistischen Screening (V1) erstmals auffällt, wird beraten. Ein Arzt, gegen den eine Krankenkasse einen Einzelfallantrag stellt (V2), wird direkt sanktioniert. Da die Einzelfallprüfung nach Schritt 0 nahezu deterministisch verläuft (dies gilt insbesondere für V2b; bei V2a bestehen Verteidigungsmöglichkeiten) (die Kasse wählt gezielt Fälle mit formaler Angreifbarkeit), fehlt der Beratungsschutz ausgerechnet dort, wo die Regresswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Die vollständige Analyse findet sich in ST-001, Abschn. 2.1–2.2.

3.5 Bürokratiekosten und Kodierungskomplexität

3.5.1 Zeitaufwand

Bereich	Aufwand	Quelle
Klinikärzte	3 h/Tag (44 % der Arbeitszeit)	MB-Monitor 2024 (n=9.649)
Niedergelassene	7,4 h/Woche = 61 Arbeitstage/Jahr	KBV Bürokratieindex
Kosten ambulant	4,33 Mrd. EUR/Jahr	Statistisches Bundesamt
Kosten Gesamtsystem	40,4 Mrd. EUR/Jahr	Healthcare-in-Europe
Informationspflichten	371 verschiedene	Statistisches Bundesamt
Berufsausstieg-Erwägung	28 % der Klinikärzte	MB-Monitor 2024

3.5.2 16.000 ICD-Codes — ein eigener Beruf

Die ICD-10-GM umfasst ca. 13.000–16.000 terminale Codes auf fünf Hierarchieebenen mit jährlicher Aktualisierung. Im stationären Bereich existiert dafür ein eigenständiger Beruf: die *Kodierfachkraft* (IHK-zertifiziert, 6–12 Monate Weiterbildung). Im ambulanten Bereich muss der Arzt diese Aufgabe **zusätzlich zu seiner medizinischen Tätigkeit** selbst übernehmen.

International ist das die Ausnahme: In Großbritannien kodiert der *Clinical Coder* (NCCQ-zertifiziert), in den Niederlanden vereinfacht das DBC-System die Abrechnungslogik erheblich.

3.5.3 Einzige Branche ohne Fehlertoleranz

Branche	Umgang mit Formfehlern
Steuerrecht	Korrektur jederzeit (§§ 129, 153, 173 AO). Differenzierung Versehen/Vorsatz.
Verwaltungsrecht	Heilung gesetzlich vorgesehen (§ 45 VwVfG). Rückwirkend möglich.
Baurecht	Formfehler nach Rügefrist (1 Jahr) unbeachtlich (§§ 214–215 BauGB).
Gesundheitswesen	**Keine Heilung.** Jeder Kodierfehler wird finanziell sanktioniert (§ 275c SGB V).

Das Gesundheitswesen unterscheidet sich durch das Fehlen kodifizierter Fehlertoleranz bei Formfehlern in Verordnungen grundlegend von anderen regulierten Branchen.

3.6 Formfehler und Eigentumsparadoxon

3.6.1 BSG B 6 KA 9/24 R: 491.000 EUR für einen Stempel

Am 27. August 2025 bestätigte das Bundessozialgericht einen Regress von 491.000 EUR über 14 Quartale — weil ein Arzt seine Verordnungen mit Namensstempel statt persönlicher Unterschrift gezeichnet hatte. Die medizinische Korrektheit der Verordnungen war unbestritten. Das BSG urteilte: Die persönliche Unterschrift sei kein bloßer Formalakt, sondern diene dem “Schutz des Lebens”. Eine nachträgliche Heilung des Formfehlers wurde nicht zugelassen.

Die KBV nannte das Urteil “unverhältnismäßig und überzogen”. Die KV Baden-Württemberg sprach von einem “Schlag ins Gesicht der Ärzteschaft”. Der betroffene Arzt kündigte eine Verfassungsbeschwerde an.

3.6.2 Tatsächlicher Schaden: Null

Bei einem Formalregress hat die Krankenkasse für eine medizinisch korrekte Verordnung bezahlt. Hätte der Arzt formfehlerfrei verordnet, hätte die Kasse **denselben Betrag** zahlen müssen. Der tatsächliche Mehrschaden ist Null. Dennoch: voller Regress in Höhe von 100 % der Verordnungskosten.

Die KBV fordert eine **Differenzkostenberechnung**: Regress nur auf den tatsächlichen Mehrschaden begrenzen. Diese Forderung blieb bislang ohne gesetzliche Umsetzung.

3.6.3 Das Eigentumsparadoxon

Nach einem Formalregress hat der Arzt für ein Medikament bezahlt, dessen Eigentümer er nie war:

- Das Medikament ging vom Hersteller über den Großhandel an die Apotheke und von dort an den Patienten (Eigentumsübergang nach § 929 BGB).
- Der Arzt hat *verordnet*, nicht *gekauft*.
- Eine Rückforderung vom Patienten scheitert (§ 812 BGB: kein Leistungsverhältnis Arzt–Patient).
- Das Medikament ist durch Verbrauch untergegangen (§ 90 BGB).

Der Arzt bezahlt für etwas, das er nie besaß, das nicht mehr existiert und das dem Patienten genützt hat.

3.7 Konkrete Patientenschäden

Die Regressangst führt zu messbarer Fehlversorgung — nicht in Einzelfällen, sondern systemisch. Die Fehlversorgung ist *bidirektional*: Einerseits unterlassen Ärzte notwendige Verordnungen (Unterversorgung), andererseits veranlassen sie unnötige Absicherungsdiagnostik und Überweisungen (Überversorgung an anderer Stelle). In beiden Fällen trägt der Patient die Last — durch verzögerte Therapie oder unnötige Eingriffe (ausführlich: ST-001, Teil VI). Die folgenden Fälle sind anonymisiert und dokumentiert.

Fall 1: Physiotherapie-Regress — 65.000 EUR

Ein Allgemeinarzt aus Nordrhein-Westfalen verordnete zwischen 2002 und 2006 doppelt so viel Physiotherapie wie der Fachgruppendurchschnitt — weil seine Patienten es brauchten. Seine Praxis versorgte überdurchschnittlich viele multimorbide und geriatrische Patienten. Die Prüfungsstelle verglich ihn trotzdem mit dem statistischen Mittel seiner Fachgruppe und erkannte keine Praxisbesonderheiten an. Regressforderung: 65.000 EUR über vier Jahre.
Quelle: Deutsches Ärzteblatt, „Kein Arzt wird für seine teuren Patienten bestraft“
Dieser Fall zeigt, dass das V1-Schutzstufenmodell nur greift, wenn Praxisbesonderheiten aktiv und korrekt angemeldet werden.

Fall 2: Sechsstelliger Heilmittelregress — Daten lagen vor

Mehrere Ärzte reichten Praxisbesonderheiten bei der Prüfungsstelle ein und erhielten trotzdem existenzbedrohende Regressforderungen. Die Begründung der Ablehnung: „Die Versichertennummern der betroffenen Patienten seien nicht genannt“ — obwohl diese bereits im Datensatz enthalten waren. Der Ablehnungsbescheid umfasste über 200 Seiten und lag ausschließlich in Papierform vor.
Quelle: Virchowbund Praxisberatung, „Praxiswahnsinn Teil 03“

Fall 3: Cannabis — Vaporizer genehmigt, Blüten regressiert

Ein Arzt verordnete einem Patienten Cannabis-Extrakt, das die Krankenkasse genehmigte. Im Behandlungsverlauf stellte er auf Blüten um und beantragte einen Vaporizer. Die Kasse genehmigte auch den Vaporizer — regressierte dann aber die Blüten, weil die Änderung der Darreichungsform nicht vorab beantragt worden war.
Quelle: Virchowbund Praxisberatung, „Praxiswahnsinn Teil 01“

Fall 4: GLP-1 bei Diabetes und Leberzirrhose — Arzt verordnet nicht, Kasse darf nicht genehmigen

Ein Patient mit einer komplexen Stoffwechselerkrankung erhält ein leitliniengerecht verordnetes Präparat, das vom G-BA mit Zusatznutzen bewertet und von einer spezialisierten Klinik empfohlen wurde. Der Hausarzt setzt die Verordnung aus: Regressangst. Der Patient beantragt eine Kostenübernahme-Bestätigung bei seiner Krankenkasse. Die Kasse antwortet formal korrekt: Eine Vorab-Genehmigung von Arzneimitteln ist gesetzlich verboten (§ 29 BMV-Ä). Der Patient erhält stattdessen ein Alternativpräparat, das seine Grunderkrankung verschlimmert.
Anonymisierter Fallbericht. Dokumentation liegt vor.

Fall 5: Onkologie — 60% Off-Label, 100% Regressrisiko

Bis zu 60 % der Krebspatienten in der Regelversorgung werden off-label behandelt, weil die Wissenschaft schneller ist als die Zulassung. Obwohl das BSG Off-Label-Verordnungen unter bestimmten Bedingungen erlaubt (BSG B 1 KR 37/00 R), regressierten Krankenkassen Onkologen für medizinische Standardtherapien wie Folinsäure/5-Fluorouracil bei metastasiertem Kolonkarzinom oder Pamidronat bei Mammakarzinom. Die DGHO warnte bereits 2006: Ärzte stehen im Dilemma — Off-Label verordnen bedeutet Regressrisiko, nicht verordnen bedeutet Haftung wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Forderung der DGHO nach einer Beweislastumkehr blieb bis heute unerfüllt.
Quellen: Deutsches Ärzteblatt 13/2002; DGHO-Stellungnahme an G-BA, 25.01.2006; KBV-Pressemitteilung 04.07.2024

3.7.1 Systemische Muster

Die Einzelfälle illustrieren wiederkehrende Muster:

- **Quartalsende-Effekt:** Ärzte vermeiden am Quartalsende teure Verordnungen, um Budgetwerte nicht zu überschreiten (§§ 106, 106b SGB V; vgl. ST-001). Die Unterversorgung

folgt dem Kalender.
- **Überweisungskaskade:** Ärzte überweisen an Fachärzte, um das Verordnungsrisiko abzuwälzen — Mehrkosten für das System, Wartezeiten für Patienten, aber der Regress liegt beim anderen.
- **Behandlungsparadox:** Die Werte sind gut, *weil* das Medikament wirkt. Das Medikament abzusetzen wegen guter Werte ist wie den Regenschirm wegzuwerfen, weil man trocken ist.
- **Der gesetzlich eingebaute Interessenkonflikt:** Der Arzt soll nach § 12 SGB V ausreichend und zweckmäßig versorgen, wird aber durch § 106b SGB V für Formfehler bei genau dieser Versorgung sanktioniert — ohne Beratungsschutz. Der Konflikt ist nicht still und nicht selten: 72 % der Hausärzte berichten eigene Regresserfahrung (Ribbat 2023; V1+V2 zusammen).

3.8 Vertraulicher Erstattungsbetrag — das Paradoxon

Seit August 2025 gilt für Mounjaro ein vertraulicher Erstattungsbetrag. Ärzte kennen den tatsächlichen GKV-Preis nicht. Die KBV (Dr. Steiner, Feb. 2025): "Ärzte verantworten den indikationsgerechten Einsatz, nicht jedoch den verhandelten Preis."

Das Dilemma: Ärzte sollen wirtschaftlich verordnen, kennen aber den Preis nicht. Will die Kasse einen Regress beziffern, muss sie den vertraulichen Erstattungsbetrag offenlegen — was die Vertraulichkeit bricht. Den Listenpreis als Regressbetrag anzusetzen wäre sachlich falsch, weil die Kasse tatsächlich weniger zahlt. Das Deutsche Ärzteblatt formuliert: “Es gibt entweder keine Regresse oder keine vertraulichen Erstattungspreise. Beides zusammen geht nicht.” Die Frage ist juristisch ungeklärt; die Befristung der Regelung bis Juni 2028 mit Evaluationspflicht bis Ende 2026 zeigt den Klärungsbedarf.

3.9 Was daraus folgt: Warum diese Datenlücken geschlossen werden müssen

Die in Abschnitt 3.4 dokumentierten Datenlücken sind nicht zufällig — sie sind strukturell. Solange sie bestehen:

- Können Ärzte ihr tatsächliches V2-Risiko nicht einschätzen (Verfahrensdaten nicht publiziert)
- Können Fachgesellschaften keine evidenzbasierten Stellungnahmen verfassen
- Kann die Politik keine informierten Entscheidungen treffen
- Bleiben die Kosten der Prüfungsinfrastruktur unbilanziert (Niskanen-Befund, ST-001 Abschn. 5.3)
- Bleibt die Wirkung des Systems auf die Versorgungsqualität unmessbar

Ein Transparenzportal, das anonymisierte Regress-Meldungen von Ärzten systematisch erfasst, würde erstmals empirische Daten liefern, die das System selbst nicht produziert: V2-Verfahrensausgänge, Formfehler-Anteile, Vergleichsquoten, regionale Unterschiede. **Neu durch CORE4:** Das Portal könnte insbesondere die bisher unbekannte **V2a/V2b-Verteilung** empirisch leisten — d. h. messen, welcher Anteil der Regresse medizinisch begründbare Evidenzsteuerung (V2a, geschätzt $\sim$35 %) und welcher reine Formalkontrolle (V2b, $\sim$40 %) ist. Diese Differenzierung existiert in keiner offiziellen Statistik und wäre ein originärer Beitrag des Portals. Das schließt nicht alle Lücken (dafür braucht es IFG-Anfragen und institutionelle Reformen), aber es schafft die **Datengrundlage für eine evidenzbasierte Reformdebatte**.

Einordnung im Lösungsraum: ST-001 (Teil VIII) bewertet 14 mögliche Interventionen in einer Kosten-Nutzen-Analyse. Der effizienteste Einzelhebel ist die Streichung des Beratungsschutz-

Ausschlusses in § 106b Abs. 2 S. 4 (Rang 1: ein Halbsatz, keine Kosten, sofortige Wirkung). Das Transparenzportal (PP-003) ist Rang 7: moderater Aufwand (800–2.500 EUR MVP), hohe Datenqualität, aber keine direkte Systemreform. *PP-003 ist der Plan B, der den Plan A erzwingen soll:* Wenn die empirischen Daten des Portals zeigen, dass V2-Regresse häufiger und existenzbedrohender sind als die offizielle Statistik suggeriert, entsteht der politische Druck für die effizienteren Hebel (Rang 1–6). Das Portal ist damit kein Selbstzweck, sondern ein **Katalysator für evidenzbasierte Reformen**.

4 Marktlücke und Alleinstellung

4.1 Was existiert

Akteur	Was er tut	Was fehlt
Therapiefreiheit e.V. (seit 2006)	Regressschutz-Versicherung, Rechtsberatung	Keine Datenbank, keine Veröffentlichung
MEZIS e.V. (seit 2007)	Pharma-Transparenz, leitlinienwatch.de	Kein Regress-Fokus
KBV	Bundestags-Petition 158622, politische Lobby	Keine Einzeldaten, keine Plattform
KV RLP	Regress-Ranking (Top-10 Kassen)	Nur eine KV-Region, nur Kassen-Rankings
KV-interne Statistiken	Aggregierte Prüfzahlen	Nicht öffentlich, nicht arzt-gesteuert

4.2 Was gebraucht wird, um die Datenlücken zu schließen

- **Anonyme, arzt-gesteuerte Meldeplattform** mit verifizierten Daten
- **Bundesweite Abdeckung** (nicht nur eine KV-Region)
- **Granulare Auswertungen** nach: KV-Bezirk, Fachgruppe, Wirkstoffgruppe, Kasse, Jahr
- **Öffentliches Dashboard** mit aggregierten Trends
- **Policy Briefs** auf Basis der gesammelten Daten

4.3 Internationale Einordnung

Es gibt weltweit keine vergleichbare Plattform:

- **USA:** Open Payments (CMS) — Pharma-Zahlungen, nicht Regresse
- **UK:** NHS Overprescribing Review — staatlich, nicht partizipativ
- **Schweiz:** physicianprofiling.ch — Methodenkritik, keine Meldeplattform

→ **First-Mover-Vorteil international.**

5 Rechtliche Bewertung

5.1 Gesamtbewertung

Rechtsgebiet	Risiko	Bewertung
DSGVO (bei Anonymisierung)	**Gering**	Anonyme Daten fallen nicht unter DSGVO (ErwGr. 26)
Re-Identifizierung	**Mittel**	Hauptrisiko — beherrschbar durch k-Anonymität (k≥5)
Schweigepflicht § 203 StGB	**Gering**	Regressdaten = wirtschaftliche Daten des Arztes, keine Patientendaten
Berufsrecht Ärztekammer	**Gering**	Keine Norm verbietet Mitteilung eigener wirtschaftlicher Daten
UWG / Wettbewerbsrecht	**Sehr gering**	Gemeinnütziger Verein = kein geschäftliches Handeln
Kartellrecht / Boykott	**Sehr gering**	Transparenz ≠ Boykottaufruf (BVerfG Lüth-Urteil 1958)
Haftung für falsche Daten	**Mittel**	Beherrschbar: Disclaimer + Notice-and-Takedown
DDG/DSA Haftungsprivileg	**Schutz vorhanden**	Art. 6 DSA bei Trennung Rohdaten vs. redaktionelle Auswertung
Pressefreiheit Art. 5 GG	**Starker Schutz**	+ Wissenschaftsfreiheit + Meinungsfreiheit

5.2 Stärkstes Argument: KV RLP Präzedenzfall

Die KV Rheinland-Pfalz veröffentlicht seit 2025 ein öffentliches Regress-Ranking mit Kassen-Rankings nach § 106b/106d SGB V. Wenn eine Körperschaft des öffentlichen Rechts solche Daten publiziert, ist es einem gemeinnützigen Verein erst recht nicht verwehrt.

- Quelle: https://www.kv-rlp.de/praxis/berufspolitik/regress-ranking

5.3 Rechtliche Pflichten des Betreibers

Pflicht	Grundlage	Status
Impressum	§ 5 DDG	Pflicht
Datenschutzerklärung	Art. 13/14 DSGVO	Pflicht
Verarbeitungsverzeichnis	Art. 30 DSGVO	Pflicht
DSFA (Datenschutz-Folgenabschätzung)	Art. 35 DSGVO	Dringend empfohlen
Datenschutzbeauftragter	Art. 37 DSGVO / § 38 BDSG	Freiwillig empfohlen
Notice-and-Takedown-Verfahren	Art. 6 DSA	Pflicht
TOM (technisch-organisatorische Maßnahmen)	Art. 32 DSGVO	Pflicht

5.4 DSGVO-Matrix: Rechtsgrundlagen explizit

Die folgende Matrix dokumentiert die DSGVO-Rechtsgrundlagen für jede Verarbeitungsstufe des Portals. Sie ist für externe Prüfer (Datenschutzbeauftragte, Fördermittelgeber) eine vorbereitende Selbstauskunft.

Verarbeitung	Datenkategorie	Rechtsgrundlage	Status
EFN-Verifizierung	Personenbezogen (Arzt)	Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag mit Nutzer) + Einwilligung (lit. a)	Pflicht
Speicherung gehashter EFN	Pseudonymisiert	Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse: Doppelregistrierungsschutz)	Zulässig
Anonyme Meldedaten	**Nicht personenbezogen** (ErwGr. 26)	DSGVO nicht anwendbar nach Erwägungsgrund 26	Außerhalb DSGVO
Aggregierte Auswertung (k≥5)	Anonymisiert	Art. 89 DSGVO (Forschungs- und Statistikprivileg) als Zusatzlegitimation	Zulässig
Veröffentlichung Dashboard	Aggregierte Statistik	Art. 5 GG (Pressefreiheit) + Art. 89 DSGVO + KV RLP-Präzedenz	Zulässig
Server-Logs (max. 7 Tage)	IP-Adressen (kurz)	Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (IT-Sicherheit)	Zulässig

Wichtige Abgrenzung Art. 9 DSGVO (besondere Kategorien): Die anonymisierten Meldedaten enthalten **keine Gesundheitsdaten** im Sinne des Art. 9 Abs. 1 DSGVO. Sie sind wirtschaftliche Daten des Arztes (Regressforderung, Wirkstoffgruppe ATC-Level 2, KV-Bezirk), nicht klinische Daten eines Patienten. Damit greift das verschärfte Verarbeitungsregime des Art. 9 nicht. Die ATC-Level-2-Aggregation (Wirkstoffgruppe statt Einzelpräparat) verhindert zusätzlich Ableitungen über konkrete Patientensituationen.

Forschungsprivileg Art. 89 DSGVO: Da das Portal explizit der Versorgungsforschung und der Erkenntnisgewinnung über regulatorisch induzierte Unterversorgung dient, greift ergänzend das Forschungsprivileg. Dieses erlaubt eine erweiterte Verarbeitung mit klaren Schutzmaßnahmen (Pseudonymisierung, k-Anonymität, Verarbeitungsverzeichnis).

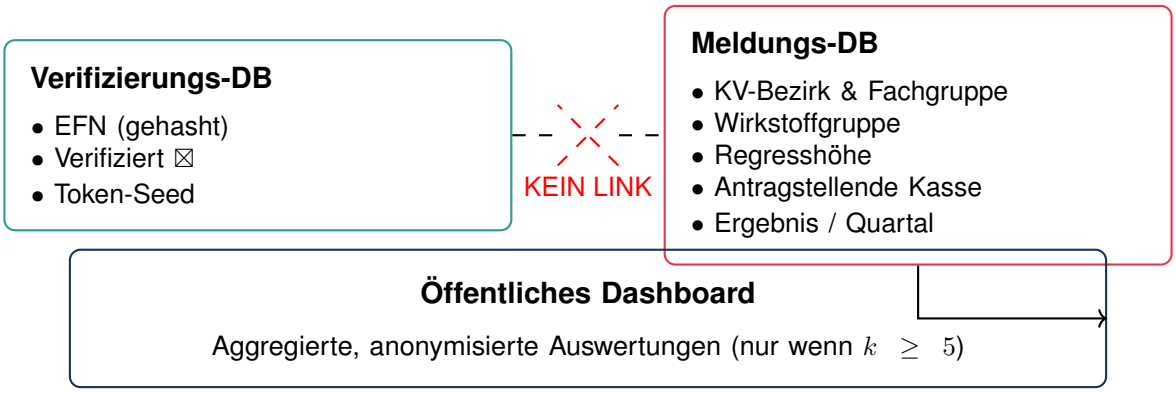
5.5 Vorsorge: Rechtsanwaltliche Prüfung

Vor Go-Live sollte eine einmalige Prüfung durch einen Fachanwalt für Medienrecht + Datenschutzrecht erfolgen. Geschätzte Kosten: 500–1.500 EUR. Die obige DSGVO-Matrix dient als Vorabklärung — sie ersetzt nicht die anwaltliche Prüfung, beschleunigt sie aber erheblich.

6 Technisches Konzept

6.1 Architekturprinzip: Wahlkabine

Das System trennt strikt zwischen **Identitätsverifizierung** und **Meldungsdaten**:

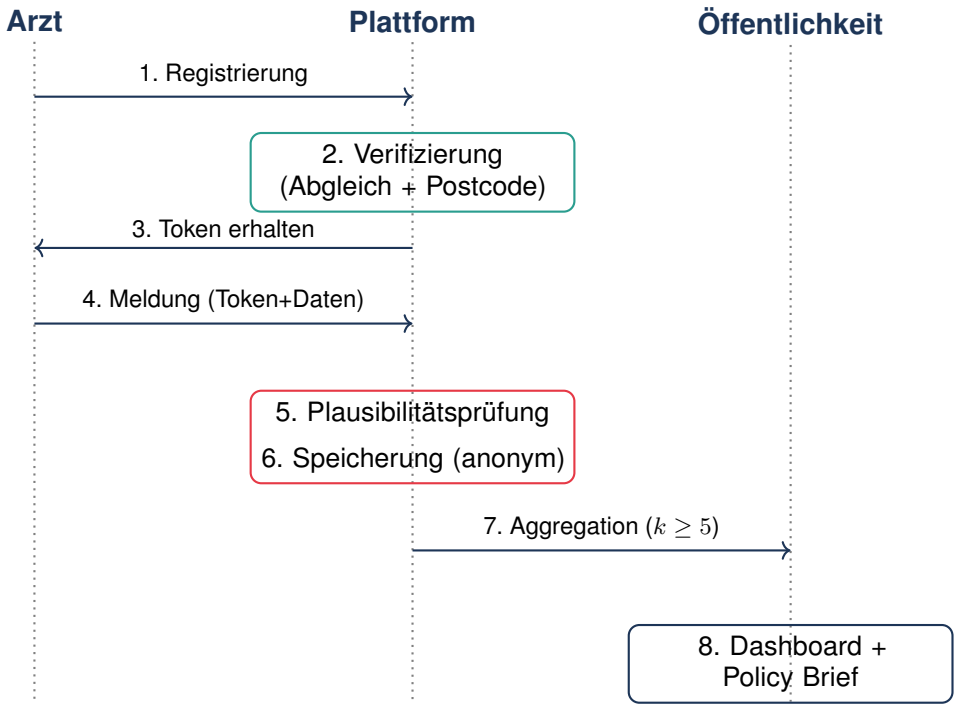


Prinzip: Vom anonymen Meldungs-Token kann nicht auf die EFN zurückgeschlossen werden (kryptographische Einweg-Ableitung). Die Verifizierungsdatenbank weiß nicht, welche Meldungen ein Arzt gemacht hat. Die Meldungsdatenbank weiß nicht, welcher Arzt gemeldet hat.

6.2 Tech-Stack (MVP)

Komponente	Technologie	Begründung
Frontend	Astro + Svelte (bereits im .UMBRUCH Website-Projekt)	Schnell, leicht, SSG+SSR
Backend/API	Node.js oder Python (FastAPI)	Einfach, bewährt
Datenbank	SQLite (MVP) → PostgreSQL (Skalierung)	Minimal, portabel
Hosting	Eigener Server (Deutscher Serverstandort, DSGVO-konform)	Volle Kontrolle, DSGVO-konform
Kryptographie	bcrypt/argon2 für EFN-Hashes, CSPRNG für Tokens	Standard, bewährt
Dashboard	Chart.js oder D3.js	Interaktiv, Open Source
Formulare	Strukturiert (Dropdowns), kein Freitext	Gegen Fakes, leicht auswertbar

6.3 Datenfluss



7 Datenarchitektur und Anonymisierung

7.1 Meldungsfelder (strukturiert, Dropdowns)

Feld	Typ	Optionen	Pflicht
KV-Bezirk	Dropdown	17 KV-Bezirke	Ja
Fachgruppe	Dropdown	20 Gruppen (aggregiert)	Ja
Wirkstoffgruppe	Dropdown	30 Gruppen (ATC-Level 2)	Ja
Antragstellende Kasse	Dropdown	Top-20 Kassen + SSonstige"	Ja
Art des Verfahrens	Dropdown	Einzelfallprüfung / Auffälligkeitsprüfung / Richtgrößenprüfung	Ja
Ergebnis	Dropdown	Regress / Beratung / Freispruch / laufend	Ja
Regresshöhe	Bereichs-Dropdown	<500€ / 500-2.000€ / 2.000-5.000€ / 5.000-20.000€ / >20.000€	Bei Regress
Zeitraum	Dropdown	Quartal + Jahr	Ja
Wurde Praxisbesonderheit anerkannt?	Ja/Nein/k.A.		Optional
Freitext-Kommentar	Textarea (max. 500 Zeichen)		Optional

Kein Freitext für identifizierende Felder. Alles strukturiert = schwerer zu fälschen, leichter

auszuwerten.

7.2 Anonymisierungsregeln

Regel	Umsetzung
k-Anonymität (k $\geq$ 5)	Jede veröffentlichte Zelle muss $\geq$ 5 Meldungen enthalten
Aggregierungsebene	KV-Bezirk (nicht Landkreis), Fachgruppe (nicht Spezialisierung)
Wirkstoffgruppe	ATC-Level 2 (z.B. “A10BJ — GLP-1-Rezeptoragonisten”), nicht Einzelpräparat
Regresshöhe	Bereiche, nicht exakte Beträge
Suppression	Zellen mit < 5 Meldungen werden als "k.A.ängezeigt
Freitext-Review	Kommentare werden vor Veröffentlichung manuell geprüft
Re-Identifizierungs-Test	Vor jeder neuen Auswertung: Kann diese Kombination eine Person identifizieren?

7.3 Datenaufbewahrung

- Meldungsdaten: Unbegrenzt (anonymisiert)
- Verifizierungsdaten (gehashte EFN): Solange Account aktiv
- Server-Logs: Max. 7 Tage, keine IP-Adressen in Meldungslogs
- Backups: Verschlüsselt, nur Meldungsdatenbank (nicht Verifizierungsdatenbank)

8 Identitätsverifizierung

8.1 Anforderung: Nur Ärzte, aber anonym

Das zentrale Problem: Sicherstellen, dass nur approbierte Ärzte melden, ohne ihre Identität mit den Meldungen zu verknüpfen.

8.2 Empfohlenes Verfahren (Phasenmodell)

1. Arzt gibt seine **Einheitliche Fortbildungsnummer (EFN)** ein 2. System prüft: Ist diese EFN einem realen Arzt zugeordnet? (Abgleich gegen öffentliches Verzeichnis der Landesärztekammern) 3. **Aktivierungscode wird per Post** an die im Arztregister hinterlegte Praxisadresse geschickt 4. Arzt gibt Code online ein $\rightarrow$ Account verifiziert 5. System generiert einen **anonymen Session-Token** (kryptographisch, kein Rückschluss auf EFN möglich) 6. EFN wird als Einweg-Hash gespeichert (verhindert Doppelregistrierung, aber keine Identifikation)

Vorteile:

- Praxisadressen sind öffentlich (KV-Arztsuche) $\rightarrow$ schwer zu fälschen
- Kein sensibles Dokument hochzuladen (keine Approbationsurkunde)
- Postweg = physische Verifikation
- EFN ist bundesweit eindeutig

Kosten: Porto (1 EUR/Arzt) + Druckkosten $\rightarrow$ vernachlässigbar

- Integration des **elektronischen Heilberufsausweises (eHBA)**
- Seit 01/2021 Pflicht für alle Vertragsärzte
- Höchste Verifikationsstufe
- Technisch aufwändiger (Chipkarten-Lesegerät, Middleware)

- Viele Ärzte haben Fax, aber kein Chipkartenlesegerät
- Fax an Praxis-Faxnummer mit Aktivierungscode
- Praxis-Faxnummern sind öffentlich

8.3 Methodisches Prinzip: Statistische Robustheit vor absoluter Verifikation

Das Portal kann nicht und muss nicht verhindern, dass jede einzelne Meldung individuell verifizierbar ist. Es muss verhindern, dass das aggregierte Bild durch koordinierte Manipulation oder Einzelfälschungen verzerrt wird. Das ist ein wichtiger methodischer Unterschied:

- **Was nicht das Ziel ist:** Jede Meldung beweisen, jede Fälschung ausschließen, jeden Einzelfall validieren.
- **Was das Ziel ist:** Statistische Aussagen, deren Gültigkeit von der Verteilung der Meldungen abhängt, nicht von der Korrektheit jeder einzelnen.

Die Anti-Fake-Strategie zielt deshalb primär auf **statistische Ausreißererkennung**, **Volumenbegrenzung pro Meldender:m** (Rate-Limiting) und **Plausibilitätsprüfung** (Regresshöhen-Bereiche). Eine einzelne falsche Meldung verzerrt das Bild kaum, wenn das Portal hinreichend viele Meldungen aggregiert. Eine koordinierte Manipulation wäre statistisch detektierbar.

Dieses Prinzip schützt vor dem klassischen Vorwurf “Einzelfälle könnten erfunden sein”. Die Antwort lautet: Ja, einzelne Meldungen können falsch sein. Aber das aggregierte Bild ist gegen einzelne Falschmeldungen robust, weil es nicht auf jeder einzelnen Meldung beruht, sondern auf der Verteilung vieler Meldungen.

8.4 Anti-Fake-Maßnahmen

Maßnahme	Gegen was	Aufwand
EFN + Postverifikation	Nicht-Ärzte	Hoch (physisch)
Rate-Limiting (1 Meldung/Quartal)	Massenfakes	Gering
Plausibilitätsprüfung (Regresshöhe)	Unrealistische Werte	Gering
Strukturierte Eingabe (Dropdowns)	Willkürliche Freitext-Fakes	Gering
Captcha + Honeypot	Bots	Gering
Statistische Ausreißererkennung	Koordinierte Manipulationen	Mittel
Doppelregistrierungssperre (EFN-Hash)	Mehrfachaccounts	Gering

8.5 Was NICHT funktioniert

Methode	Warum nicht
Nur E-Mail-Verifizierung	Wegwerf-Mails, keine Identitätsprüfung
Wissensfragen ("EBM-Code für...")	Googelbar
Selbstauskunft ("Ich bin Arzt")	Wertlos
Approbationsurkunde hochladen	Fälschbar, DSGVO-problematisch
Social-Media-Verifizierung	Nicht alle Ärzte haben Profile

9 MVP-Definition

9.1 Scope MVP (v0.1)

In Scope:

- [x] Registrierung mit EFN + Postverifikation
- [x] Anonyme Meldung (strukturierte Felder, Dropdowns)
- [x] Einfaches öffentliches Dashboard (Balkendiagramme nach KV-Bezirk, Fachgruppe, Kasse)
- [x] k-Anonymitätsprüfung vor Veröffentlichung
- [x] Impressum, Datenschutzerklärung, Disclaimer
- [x] Notice-and-Takedown-Verfahren
- [x] Responsives Design (Desktop + Mobile)

Nicht in Scope (v0.1):

- [ ] eHBA-Integration
- [ ] Zeitreihenanalysen
- [ ] API für Drittanbieter
- [ ] Mehrsprachigkeit (EN)
- [ ] Podcast/Video-Content
- [ ] Policy Briefs (ab v0.2)

9.2 Erfolgskennzahlen MVP

KPI	Zielwert (6 Monate)	Messung
Verifizierte Ärzte	$\geq$ 50	Registrierungsdatenbank
Meldungen	$\geq$ 100	Meldungsdatenbank
Dashboard-Aufrufe	$\geq$ 1.000	Analytics (datenschutzkonform)
Medienberichterstattung	$\geq$ 1 Artikel	Presseclipping
Kooperationsanfragen	$\geq$ 1	Posteingang

10 Governance und Betrieb

10.1 Anforderungen an die Trägerorganisation

Eine geeignete Trägerschaft erfüllt idealerweise folgende Voraussetzungen:

- Anerkannte Gemeinnützigkeit nach § 52 AO, vorzugsweise mit Satzungszwecken in den Bereichen:
  - Förderung der Volksbildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO)
  - Förderung des demokratischen Staatswesens (§ 52 Abs. 2 Nr. 24 AO)
  - Wissenschaft und Forschung (§ 52 Abs. 2 Nr. 1 AO)
- Erfahrung mit datenschutzsensiblen Plattformen (DSGVO-Compliance, DSFA)
- Zugang zur Ärzteschaft oder Bereitschaft, Kooperationen mit Fachgesellschaften und Berufsverbänden aufzubauen
- Unabhängigkeit von Krankenkassen-Verbänden und Pharmaindustrie

In Frage kommen Vereine, gemeinnützige Stiftungen, Civic-Tech-Initiativen oder ärztliche Berufsverbände mit erweiterter Satzung.

10.2 Rollen-Struktur

Rolle	Verantwortung	Besetzung
Vorstand / Projektleitung	Strategie, Finanzen, Kooperationen	Trägerorganisation
Technik	Entwicklung, Hosting, Sicherheit	Trägerorganisation + Open-Source-Community
Datenschutz	DSFA, Anonymisierung, Compliance	Externer Datenschutzbeauftragter
Redaktion	Policy Briefs, Dashboard-Texte	Vorstand + Beirat
Beirat (ab Phase 2)	Fachliche Beratung, Legitimation	3–5 Ärzte / Gesundheitspolitiker

10.3 Redaktionsrichtlinien

- **Nur aggregierte Daten** werden veröffentlicht (nie Einzelmeldungen)
- **k-Anonymität** wird bei jeder Auswertung geprüft
- **Keine namentliche Nennung** einzelner Ärzte (auch nicht indirekt)
- **Krankenkassen werden genannt** (sind öffentliche Körperschaften, KV RLP macht es vor)
- **Disclaimer** auf jeder Seite: NNicht verifizierte Eigenmeldungen. Keine Gewähr für Richtigkeit."
- **Stellungnahme-Recht:** Krankenkassen können zu den Daten Stellung nehmen

11 Finanzierung

11.1 Kosten MVP

Position	Einmalig	Laufend (monatlich)
Domain (regress-transparenz.de o.ä.)	12 EUR	1 EUR
Hosting (ellmos-services, bereits vorhanden)	0 EUR	0 EUR (anteilig)
Postversand Verifizierung (100 Ärzte)	100 EUR	—
Fachanwalt Datenschutz/Medienrecht (einmalig)	500–1.500 EUR	—
Freiwilliger DSB (einmalig Erstberatung)	200–500 EUR	—
Design / Logo	0–300 EUR	—
Entwicklung (Eigenleistung)	0 EUR	—
Gesamt MVP	**812–2.412 EUR**	**1 EUR**

11.2 Finanzierungsquellen

Quelle	Potenzial	Timeline
Eigenmittel (Bootstrap)	800–2.500 EUR	Sofort
Spenden (betterplace.org)	500–5.000 EUR/Jahr	Ab Gemeinnützigkeit
Schöpflin Stiftung (Lörrach!)	10.000–100.000 EUR	3–9 Monate
Steady / Substack	2.000–6.000 EUR/Jahr	Ab Content
EU CERV-Programm	50.000–500.000 EUR	12–24 Monate
Beratungsaufträge (KVen, Fachgesellschaften)	5.000–30.000 EUR	Ab Datenbasis

11.3 Langfristige Nachhaltigkeit

Das Portal wird mit wachsender Datenbasis wertvoller:

- **Policy Briefs** auf Basis der Daten → Auftragsforschung für KVen, DDG, KBV
- **Jahresberichte** → Medienberichterstattung → Spendenakquise
- **Kooperationen** mit Therapiefreiheit e.V., MEZIS → gemeinsame Fördermittelanträge

12 Zeitplan

12.1 Phase 1: Grundlagen (Monat 1–2)

[ ] e.V. gründen (falls noch nicht geschehen)
[ ] Gemeinnützigkeit beantragen
[ ] Domain registrieren
[ ] Fachanwalt konsultieren (Datenschutz + Medienrecht)
[ ] DSFA erstellen
[ ] Technisches Grundgerüst aufsetzen (Astro + Backend)

12.2 Phase 2: MVP-Entwicklung (Monat 3–4)

[ ] Registrierungssystem (EFN + Postverifikation)

- [ ] Meldungsformular (strukturiert)
- [ ] Anonymisierungs-Pipeline
- [ ] Dashboard (Basisversion)
- [ ] Datenschutzerklärung, Impressum, Disclaimer
- [ ] Notice-and-Takedown-Verfahren

12.3 Phase 3: Soft Launch (Monat 5–6)

- [ ] Einladung von 20–50 Ärzten (persönliches Netzwerk + Therapiefreiheit e.V.)
- [ ] Feedback einholen und iterieren
- [ ] Erste Daten im Dashboard
- [ ] Pressemitteilung vorbereiten

12.4 Phase 4: Öffentlicher Launch (Monat 7–8)

- [ ] Öffentliche Ankündigung
- [ ] LinkedIn + Fachmedien (Deutsches Ärzteblatt, Ärzte Zeitung)
- [ ] Erster Policy Brief (wenn Datenbasis ausreicht)
- [ ] Kooperationsanfragen an Therapiefreiheit e.V., MEZIS, KBV

12.5 Phase 5: Skalierung (ab Monat 9)

- [ ] eHBA-Integration prüfen
- [ ] Fördermittelanträge (Schöpflin, CERV)
- [ ] Beirat aufbauen
- [ ] Internationale Version (re:shape, EN)

13 Risiken und Gegenmaßnahmen

Risiko	Eintritt	Auswirkung	Gegenmaßnahme
Zu wenige Meldungen	Mittel	Dashboard leer, keine Relevanz	Persönliche Ansprache über Fachgesellschaften, Therapiefreiheit e.V.
Fake-Meldungen	Gering	Datenqualität sinkt	Postverifikation + Rate-Limiting + Plausibilitätsprüfung
Abmahnung durch Krankenkasse	Gering	Kosten, Aufwand	Fachanwalt vorab, Notice-and-Takedown, Art. 5 GG
Re-Identifizierung eines Arztes	Gering	Datenschutzverstoß	k-Anonymität ($k \geq 5$), Aggregierung, DSFA
Negative Medienberichterstattung	Sehr gering	Reputationsschaden	Transparente Kommunikation, Disclaimer
Technischer Ausfall / Hack	Gering	Datenverlust	Backups, keine sensiblen Daten in Meldungs-DB
Keine Gemeinnützigkeit erhalten	Gering	Keine Spendenquittungen	Satzung vorab vom Finanzamt prüfen lassen

14 Kooperationspartner

14.1 Priorität 1 (sofort ansprechen)

Partner	Warum	Kontakt
Therapiefreiheit e.V.	Größtes Netzwerk, Zugang zu regressierten Ärzten	therapiefreiheit.org
KV Rheinland-Pfalz	Betreiben bereits Regress-Ranking, Vorbild	kv-rlp.de
DDG (Deutsche Diabetes Gesellschaft)	GLP-1-Regress ist deren Kernthema	ddg.info

14.2 Priorität 2 (ab Phase 4)

Partner	Warum
MEZIS e.V.	Transparenz-Expertise, leitlinienwatch.de
KBV	Bundestags-Petition, politischer Hebel
Virchowbund	Ärzte-Verband, Reichweite
UPD (Unabhängige Patientenberatung)	Patientenperspektive
FragDenStaat / OKF	Transparenz-Expertise, technisch

14.3 Priorität 3 (ab Phase 5)

Partner	Warum
Schöpflin Stiftung (Lörrach)	Regional, transformationsorientiert
Robert Bosch Stiftung	Gesellschaftliche Transformation
EU CERV-Programm	Fördermittel für Demokratie/Transparenz
Wissenschaftliche Institute (IGES, RWI)	Auswertung, Publikationen

15 Quellen und Rechtsgrundlagen

Formales Literaturverzeichnis

Literatur

[1] Lena Ribbat, Klaus Linde, Antonius Schneider, and Bernhard Riedl. Effects of recourse claims on the prescribing behavior of general practitioners and orthopedists in germany. *Das Gesundheitswesen*, 85(2):111–118, 2023.

[2] Katja Goetz et al. Defensive practices among german general practitioners. *BMC Primary Care*, 2024.

[3] Bowen Zheng et al. Defensive medicine: A systematic review and meta-analysis. *International Journal for Quality in Health Care*, 2023. 75,8% Defensivmedizin-Prävalenz global.

[4] KBV and Universität Trier. Berufsmonitoring medizinstudierende, 2018. Dritte Erhebungswelle, ca. 13.900 Befragte. 46,7% nennen Regressangst als Niederlassungshindernis.

[5] Bundesministerium für Gesundheit. Referentenentwurf gvsg, 2024. Ca. 47.000 V2-Verfahren bundesweit (2022).

[6] SpiFa. Regressdaten bayern 2023/2024, 2024. 13.332 Regresse, 4,45 Mio. EUR, Durchschnitt 334 EUR bei ca. 24.000 Ärzten.

[7] Virchowbund. Regress — selten bedrohlich, aber lästig, 2018. 0,065%: Weniger als 100 rechtskräftige Regresse bundesweit.

[8] KV Rheinland-Pfalz. Regress-ranking: Top-10 krankenkassen nach prüfanträgen. https://www.kv-rlp.de/praxis/berufspolitik/regress-ranking, 2025.

[9] Marburger Bund. Mb-monitor 2024, 2024. n=9.649. 3 h Bürokratie pro Tag bei Klinikärzten.

[10] Stiftung Datenschutz. Praxisleitfaden anonymisierung. Methodische Grundlage für Anonymisierungskonzept PP-003.

[11] AOK Baden-Württemberg. Prüfthemenliste einzelfallprüfung 2025, 2025.

[12] BSG. B 6 ka 9/24 r — formalregress 491.000 eur, 2025. Stempel statt Unterschrift bei medizinisch korrekter Behandlung.

[13] BSG. B 6 ka 5/23 r und b 6 ka 10/23 r — differenzkostenregelung, 2024. Gilt für V2a, explizit ausgeschlossen für V2b (Formfehler).

[14] BSG. B 6 ka 5/09 r — normativer schadensbegriff, 2010.

[15] BVerfG. Lüth-urteil 1958, 1958. Meinungsfreiheit bei wirtschaftlichem Nachteil.

[16] Deutscher Bundestag. Sgb v — §§ 106, 106b (wirtschaftlichkeitsprüfung). Insb. § 106b Abs. 2 S. 4 (Beratungsschutz-Ausschluss für V2).

[17] Dsgvo — datenschutz-grundverordnung. Insb. Erwägungsgrund 26 (Anonymisierung), Art. 6 (Rechtsgrundlagen).

[18] Hinschg — hinweisgeberschutzgesetz. Nicht direkt anwendbar auf PP-003, aber legitimierender Rahmen.

[19] Ddg / dsa art. 6 — haftungsprivileg für hosting-dienste. Digitale-Dienste-Gesetz, Umsetzung EU Digital Services Act.

[20] Um:bruch. St-001: Systemtheoretische aufarbeitung der regressangst, 2026. v0.12, 87 Seiten. Begleitstudie zu PP-003.

15.1 Gesetze und Verordnungen

- §§ 106, 106b SGB V — Wirtschaftlichkeitsprüfung
- § 52 AO — Gemeinnützige Zwecke
- Art. 5 GG — Meinungs-, Presse-, Wissenschaftsfreiheit
- DSGVO, insbesondere Erwägungsgrund 26 (Anonymisierung)
- § 203 StGB — Ärztliche Schweigepflicht
- DDG (Digitale-Dienste-Gesetz) / DSA Art. 6 — Haftungsprivileg
- HinSchG — Hinweisgeberschutzgesetz (nicht direkt anwendbar, aber legitimierend)

15.2 BSG-Rechtsprechung

- BSG 27.08.2025, B 6 KA 9/24 R — Formalregress 491.000 EUR (Stempel statt Unterschrift)
- BSG 05.06.2024, B 6 KA 5/23 R — Differenzkostenregelung
- BSG 05.06.2024, B 6 KA 10/23 R — Differenzkostenregelung
- BGH-Urteile zu Bewertungsportalen (kununu, Jameda)
- BVerfG Lüth-Urteil 1958 — Meinungsfreiheit bei wirtschaftlichem Nachteil

15.3 Institutionelle Quellen

- KV RLP: Regress-Ranking — https://www.kv-rlp.de/praxis/berufspolitik/regress-ranking
- KV BW: Regressgefahr — https://www.kvbawue.de/praxis/verordnungen/arzneimittel/regressgefahr
- KBV: Bundestags-Petition 158622
- DDG/BVND: Statement Tirzepatid-Verordnung 03/2024
- G-BA: Nutzenbewertung Tirzepatid 02.05.2024

15.4 Studien und Analysen

- Virchowbund: “Regress — selten bedrohlich, aber lästig”
- Ärzte Zeitung: “Regressangst der Ärzte schadet Patienten”
- Deutsches Ärzteblatt: “Große regionale Unterschiede bei Wirtschaftlichkeitsprüfungen” (Pipeline-Daten KV Hessen, KV Thüringen, KV Nordrhein)
- Deutsches Ärzteblatt: “Regressrisiko bei vertraulichen Erstattungsbeträgen bleibt unbekannt”
- KBV-Berufsmonitoring Medizinstudierende (KBV/Universität Trier 2018, dritte Erhebungswelle, ca. 13.900 Befragte): 46,7 % nennen Regressangst als Niederlassungshindernis
- MB-Monitor 2024 (Marburger Bund, n=9.649): 3 h Bürokratie pro Tag bei Klinikärzten
- KBV Bürokratieindex: 7,4 h/Woche bei Niedergelassenen
- Statistisches Bundesamt: 4,33 Mrd. EUR/Jahr Bürokratiekosten ambulant
- Goetz et al. 2024 (BMC Primary Care): Defensivmedizin bei deutschen Hausärzten
- Moosazadeh et al. 2023 (Int J Qual Health Care): Meta-Analyse Defensivmedizin (75,8 % Prävalenz)
- Stiftung Datenschutz: Praxisleitfaden Anonymisierung

16 Anhang: Namensvorschläge

Name	Domain	Bewertung
Regress-Transparenz	regress-transparenz.de	Klar, beschreibend
RegressWatch	regresswatch.de	Modern, analog zu leitlinienwatch.de
Prüfkompass	pruefkompass.de	Neutral, weniger konfrontativ
VerordnungsMonitor	verordnungsmonitor.de	Breiter angelegt

Empfehlung: “RegressWatch” — kurz, einprägsam, Parallele zu leitlinienwatch.de (MEZIS), signalisiert unabhängige Beobachtung.

Dieses Konzeptpapier wurde mit KI-Unterstützung (Claude, Anthropic) erstellt. v1.0 vom 30.03.2026, v2.0 vom 08.04.2026 mit erweiterten Recherchen zu Pipeline-Dropout, Systemwiderspruch

der Prüfverfahren, Bürokratiekosten und Formfehler-Rechtsprechung. v2.1 vom 08.04.2026 mit Verweis auf das Begleitpaper ST-001 und ergänzenden Befunden zu Niskanen-Bürokratie-Selbsterhaltung und verfassungsrechtlichen Angriffsvektoren. v2.2 vom 08.04.2026 nach Copilot-Review: Klarstellung "pro-Governance, nicht anti-Regress", explizite DSGVO-Matrix, schärfere Anti-Fake-Methodik (statistische Robustheit). Es stellt keine Rechtsberatung dar.

Verwandte Dokumente:

- **ST-001 — Systemtheoretische Aufarbeitung der Regressangst** (Begleitstudie, v0.9, 66 Seiten): historische Container-Genealogie, rechtsdogmatische Drei-Code-Kollision (§ 12 SGB V), Spieltheorie, Modellarzt-Hochrechnung (0,9–1,7 Mrd. EUR/Jahr Folgekosten), Niskanen-Bestätigung der Prüfungseinrichtungen, verfassungsrechtliche Doppelbeschwerde-Strategie, normativer Schadensbegriff (BSG B 6 KA 5/09 R), Lesart C (System als Formfehler-Optimierer), Prüfkatalog-Asymmetrie, Gegenpositions-Abschnitt (5 stärkste Einwände), Anhang C (9 IFG-Anfragen als offene Forschungsfragen).
- **Open-Source-Verordnungstool** (Software-Projekt, in Konzeption): Companion-Tool zur Regress-Prävention im Moment der Verordnung. Browser-basierter MVP, Förderprofil Prototype Fund. Empfohlene Trägerkonstellation: gemeinnützige Trägerorganisation plus medizinischer Review-Partner (z. B. Therapiefreiheit e.V.).

Dieses Konzept steht unter CC BY 4.0. Wir suchen Umsetzungspartner.

Kontakt: hallo@um-bruch.org
Web: um-bruch.org

Änderungshistorie

- **v2.8** (April 2026) — CORE4-Integration: ST-001-Referenz auf v0.12 (85 Seiten). V2-Datenabschnitt korrigiert ("Daten existieren, aber nicht integriert publiziert"; BMG 47.000, SpiFa Bayern 13.332). Definitionsdivergenz (Drei-Schichten, Faktor 500×) bei Ribbat-Diskrepanz. V2a/V2b-Verteilung als originärer PP-003-Beitrag benannt. Doppelfunktion (∼35 % Evidenzsteuerung) referenziert.
- **v2.7** (April 2026) — ST-001-Referenz auf v0.11 (76 Seiten) aktualisiert. Ribbat V1/V2-Caveat an allen Nennungen ergänzt. KNV-Einordnung: PP-003 = Rang 7 von 14 Maßnahmen, "Plan B der Plan A erzwingen soll". Goodhart's/Campbell's Law beim Zertifikatsfehler. Governance-Pharmakovigilanz als ST-001-Begriff verankert. Fehlversorgung bidirektional explizit benannt. KBV-Berufsmonitoring: Quellenverzeichnis auf 46,7 %/13.900 (2018) korrigiert.
- **v2.6** (April 2026) — ST-001-Referenz auf v0.9 (66 Seiten) aktualisiert.
- **v2.5** (April 2026) — **Großer Strukturumbau nach LG-Review (35+ Kommentare):** Abschnitt 3 komplett umgebaut: V1/V2 sauber eingeführt mit Vergleichstabelle (3.1), Systemwiderspruch vor die Zahlen gezogen (3.2), Zahlen V1/V2-attributiert (3.3), Ribbat 72 %-Befund integriert ("Angst ist berechtigt"), "Was wir nicht wissen"-Abschnitt neu (3.4), "Drei Scanner, keine Qualitätsprüfung" statt "fehlende Gegenrichtung", Abstract und Executive Summary komplett neu, Formfehler-Regress präzisiert (normativer Schadensbegriff), vertraulicher Erstattungsbetrag: Dilemma-Formulierung. 29 Seiten.
- **v2.4** (April 2026) — An ST-001 v0.8 angeglichen: Lesart C (Formfehler-Optimierer) in Lesarten-Abschnitt integriert; Prüfkatalog-Asymmetrie als Argument; ST-001-Referenz aktualisiert (63 Seiten, neue Inhalte).
- **v2.3** (April 2026) — Option B (KV-Beratung nach § 75 SGB V) und Option C (KK-Stellungnahme, BSG B 6 KA 27/12 R) als eigener Abschnitt eingearbeitet; Präzisierung: Option C schützt nur gegen KK als Antragstellerin im Einzelfallverfahren, nicht gegen Prüfungsstellen-Auffälligkeitsprüfung; IFG-Strategiebezüge; Querverweise auf ST-001 v0.6.
- **v2.2** (März/April 2026) — Copilot-Review 2 eingearbeitet: Anti-Fake-Schärfung, DSGVO-Matrix, Verweis auf Begleitstudie ST-001. 25 Seiten.
- **v2.1** (März 2026) — Kryptographisches Konzept ausgebaut (EFN-Verifizierung, k-Anonymität $k \geq 5$, Wahlkabinen-Prinzip); Träger-Suche als Konzeptangebot formuliert (Um:bruch ist Denkfabrik, nicht Umsetzer).
- **v2.0** (März 2026) — Vollständige Neufassung als Positionspapier; drei minimal-invasive Reformhebel (§ 106b Abs. 2 S. 4, Publikationspflicht § 106c, Sichtbarmachung § 48 BMV-Ä); MVP-Kalkulation 800–2.500 EUR.
- **v1.0** (März 2026) — Erstes Konzeptdokument: Portal-Architektur, Anonymisierungskonzept, Datenschutz-Grundgerüst.

KI-Transparenzhinweis

Dieses Dokument wurde unter extensivem Einsatz von KI-Sprachmodellen (u. a. Anthropic Claude, Microsoft Copilot, Google Gemini) erarbeitet. Der Einsatz war notwendig, um diese Analyse mit begrenzten Ressourcen zu ermöglichen. Es wurden mehrere Kontroll- und Reviewzyklen durchgeführt — sowohl KI-gestützt als auch durch menschliche Redaktion.

KI-Sprachmodelle neigen zu Halluzinationen und können sachliche Fehler produzieren. Trotz sorgfältiger Prüfung sind Fehler nicht ausgeschlossen. Wir korrigieren dokumentierte Fehler gerne und veröffentlichen verbesserte Versionen.

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar.

Hinweise auf Fehler bitte an: hallo@um-bruch.org